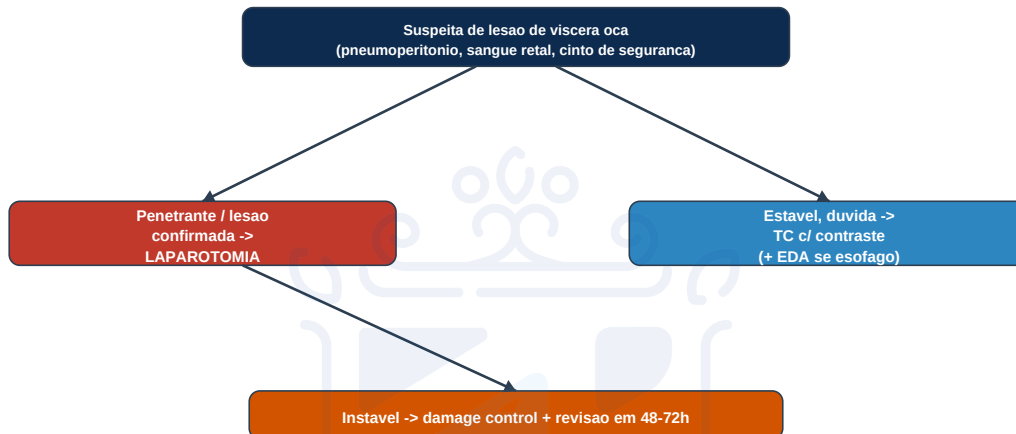


TRAUMA DO TRATO GASTROINTESTINAL

FLUXOGRAMA — VÍSCERA OCA

TRAUMA DE TGI — VÍSCERA OCA É CIRÚRGICO



DEFINIÇÃO E SUSPEITA

O QUE É

- Lesão de víscera oca por trauma; mais comum no PENETRANTE (contuso protege esôfago/estômago/duodeno)
- Lesão de víscera oca / TGI é SEMPRE cirúrgica no trauma penetrante
- Suspeita: pneumoperitônio, sangue na sonda gástrica/toque retal, achados na TC
- Esôfago/estômago/duodeno: trauma raro; delgado/cólon/reto: associados a mecanismos específicos

QUANDO SUSPEITAR — DELGADO, CÓLON E RETO

PISTAS DE LESÃO

- SINAL DO CINTO DE SEGURANÇA + fratura de Chance (vertebral)
- Líquido livre SEM lesão de víscera parenquimatosa; pneumoperitônio
- Mecanismo: queda de tanque/guidão de bicicleta sobre o tronco
- Hematoma de mesentério, alterações de parede da alça na TC
- TOQUE RETAL com sangue (lesão de reto)

ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO

Órgão	Conduta cirúrgica
Esôfago	Rafia primária + reforço (funduplicatura) + drenagem; gastro/jejunostomia. Casos graves: esofagectomia
Estômago	Lesão < 3 cm: rafia em 2 planos. Maiores: gastrectomia subtotal. Drenagem ampla se reconstrução
Duodeno	Rafia em 2 planos + drenagem ampla; derivação para desvio do trânsito se necessário. GDP é exceção (destruições)
Achado intraoperatório	Inspeção completa (parede anterior E posterior); na dúvida, 'teste do borracheiro'; lavagem e busca ativa de outras lesões

DELGADO, CÓLON E RETO

Órgão	Compensado	Damage control / grave
Delgado	Enterectomia + enteroanastomose	Sepultamento e revisão em 48-72h
Cólon	Pequena: rafia Grande: colectomia segmentar + anastomose	Damage control; colostomia em casos muito graves
Reto intraperitoneal	Pequena: rafia 2 planos Maior: rafia + drenagem + colostomia em alça + lavagem distal	Semelhante ao cólon
Reto extraperitoneal	Acesso fácil: como intraperitoneal	Difícil acesso: drenar + ostomia + lavagem (4 Ds)

CONCEITO — 4 Ds DO TRAUMA DE RETO

RETO EXTRAPERITONEAL

- Desbridamento
- Derivar (colostomia)
- Drenagem
- Distal (lavagem do coto distal)
- Reto intraperitoneal -> manejo semelhante ao cólon; extraperitoneal de difícil acesso -> 4 Ds

CONDUTA NO PS

PASSOS

- ☐ ABCDE; identificar sinais de lesão de víscera oca (pneumoperitônio, sangue na SNG/toque, cinto de segurança)
- ☐ Penetrante com lesão de TGI = laparotomia (acionar cirurgia geral)
- ☐ Estável com dúvida = TC com contraste (EDA pode preceder em suspeita de lesão esofágica)
- ☐ Instável = controle de dano (damage control) com revisão em 48-72h
- ☐ Sempre buscar lesões associadas; inspeção da parede anterior e posterior na cirurgia

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Trauma de TGI ____ (penetrante/contuso); órgão suspeito: ____ (esôfago/estômago/duodeno/delgado/cólon/reto).
- Pistas: pneumoperitônio / sangue retal / cinto de segurança / TC _____. Estabilidade: _____.
- Conduta: laparotomia / damage control / TC. Lesões associadas: _____.
- Solicito centro com cirurgia geral 24h / UTI / banco de sangue.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Ferimento penetrante abdominal com pneumoperitônio e sinais de lesão de víscera oca. Conduta?

- A) Tratamento não operatório com observação
- B) Laparotomia (lesão de víscera oca por trauma penetrante é cirúrgica)
- C) Apenas antibiótico
- D) Endoscopia ambulatorial
- E) Alta com dieta zero

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado sugere lesão de víscera oca no trauma abdominal contuso?

- A) Fratura de fêmur isolada
- B) Sinal do cinto de segurança, fratura de Chance, pneumoperitônio e toque retal com sangue
- C) Cefaleia
- D) Hematúria isolada microscópica
- E) Escoriação superficial

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é a conduta para uma lesão gástrica menor que 3 cm em paciente compensado?

- A) Gastrectomia total
- B) Rafia em 2 planos
- C) Apenas drenagem
- D) Colostomia
- E) Observação sem cirurgia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Os '4 Ds' do trauma de reto extraperitoneal incluem:

- A) Diálise, diurético, dieta, drenagem
- B) Desbridamento, derivar (colostomia), drenagem e lavagem distal
- C) Drenagem, dipirona, dieta, deambulação
- D) Descompressão, diálise, drogas, dieta
- E) Não há conduta padronizada

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

No paciente INSTÁVEL com lesão complexa de delgado/cólon, qual a estratégia cirúrgica?

- A) Anastomose primária imediata sempre
- B) Damage control (sepultamento) com revisão em 48-72h
- C) Apenas rafia simples e fechamento definitivo
- D) Observação clínica
- E) Colonoscopia de urgência

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Lesão de víscera oca por trauma penetrante é SEMPRE cirúrgica: indica-se laparotomia. Pneumoperitônio confirma a indicação. O tratamento não operatório aplica-se a lesões de vísceras parenquimatosas selecionadas.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Sinal do cinto de segurança, fratura de Chance, pneumoperitônio, líquido livre sem lesão parenquimatosa e toque retal com sangue sugerem lesão de víscera oca no trauma contuso.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Lesão gástrica < 3 cm em paciente compensado pode ser tratada com rafia em 2 planos; lesões maiores exigem gastrectomia subtotal, com drenagem ampla se houver reconstrução.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Os 4 Ds do trauma de reto (extraperitoneal) são: Desbridamento, Derivar (colostomia), Drenagem e lavagem Distal do coto — usados quando o acesso direto é difícil.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

No paciente instável com lesão complexa, aplica-se controle de dano (damage control): sepultamento/abordagem abreviada e revisão em 48-72h após estabilização, evitando anastomoses definitivas no choque.

SM24
Suporte ao Plantão Médico